

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

Dr. André

HORA QUE DORME

HORA QUE ACORDA

IAH = 66,3/ev

SONECA DURANTE O DIA

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

19/04 - Dece apresentando aerofagia

22 m. de uso: 6h

P = 10.6 cm H₂O

IAH = 3,9/ev

fua

25/04 P = 10.2 cm H₂O

22 IAH = 1,3

m. de uso: 6h

fua

03/05 P = 10.2 cm H₂O

22 IAH = 3,2

m. de uso: 5'55

fua

30/05 P = 10.2

22 IAH = 2,5

m. de uso: 6h11

fua

06/06 P = 8,2

22 IAH = 3,9

m. de uso: 6h30'

Oriento o uso do esparadrapo

fua

12/07 P = 8,2

22 IAH = 3,8

m. de uso: 6h15'

Marc. Facial

fua

11/09 P = 8,2 cm H₂O

23 IAH = 4,3 e/ev

m. de uso: 5h22'

Fuga = 35,5 l/min.

fua

13/11 P = 8,2 cm H₂O

23 IAH = 3,7 e/ev

m. de uso: 5h

01/03 P = 8,2 cm H₂O

24 IAH = 3,5 e/ev

m. de uso: 4h50'

fua

26/05/25 P = 8,2 cm H₂O

IAH = 1,2/ev

Nesta semana; só 3 dias desde Hinf

* novo filtro

P = 8,0 cm H₂O

Prompca: 5 cm H₂O

siene

02/06/25 P = 8 cm H₂O

IAH = 2,0 e/ev

m. de uso

5130

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Raimundo Alves de Sousa Filho
EXAME nº: 5075
SOLICITADO POR: Dr. André Pereira Costa
DATA: 04/03/2022
IDADE: 54 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h47min e concluído às 06h10min. A latência para o sono foi de 21 minutos e a latência para o estágio REM, de 165 minutos. O tempo total de sono foi de 304 minutos (05h04min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 61%. A distribuição do sono mostrou 26,2% de estágio 1, 38,7% de estágio 2, 24,5% de estágio 3 e 10,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 172,5 minutos em vigília, ocorreram 182 microdespertares (índice: 35,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 66,3/hora, sendo 18,2 apneia/hora e 48,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 66,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 83%.

(*) TTS ☐ Tempo Total de Sono TTR ☐ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (66,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (66,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 54; máxima: 74 bpm.

O ronco foi esporádico e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 21 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (165 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 61%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 35,9/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (26,2%; normal: 8-10%) e 3 (24,5%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (38,7%; normal: 45-55%) e REM (10,7%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 6 (normal até 9; máxima: 24).

$$\begin{array}{r} 0.9 \\ 0.6 \\ \hline 2.5 \end{array}$$

$P = 8000 \text{ kg}$
 $JAH = 1.2 \text{ e } 10$
 n. de uso: 5ms
 fuga = 72.7

$P = 8 \text{ cmHg}$
 $IAH = 1.5 \text{ atm}$
 $M - \text{de uso} = 5 \text{ h } 40'$
 $fuga = 59.4 \text{ ppm}$